

03 - 03-Hypertension Intracrânienne Et Œdèmes Cérébraux Partie2 - Pr. M. Elkhayari

(0:02 - 0:50)

Pour les conséquences, donc la première conséquence la plus grave qui peut arriver quand on a un patient en hypertension intracrânienne, c'est le risque d'engagement cérébral, c'est-à-dire le refoulement du paryngyme cérébral et la compression des structures avoisinantes. Et une partie du paryngyme va bien sûr sortir par les orifices de communication avec le compartiment voisin. Donc, soit on aura de l'engagement du paryngyme refoulé ou de la tumeur elle-même avec compression des structures avoisinantes et étranglement dans l'orifice de communication.

(0:52 - 1:35)

Il est strictement interdit de réaliser la ponction lombaire parce que c'est une manœuvre qui va aggraver le gradient de pression entre les compartiments et va favoriser les phénomènes d'engagement. Parce qu'elle va créer une dépression dans le canal rachidier, donc elle est interdite à chaque fois que l'HTIC est soupçonnée. Le deuxième risque ou la complication ou la deuxième conséquence désignée par l'enceinte intracrânienne, c'est le risque d'ischémie par bas débit sanguin cérébral.

(1:36 - 1:54)

Vous savez que le débit sanguin cérébral dépend de la pression de perfusion cérébrale et de la résistance vasculaire sinuscémique. Donc, en cas de chute de la pression de perfusion cérébrale, on va avoir une chute sur le débit sanguin cérébral et une ischémie cérébrale. Il faut dire que le débit sanguin cérébral est protégé par l'autorégulation cérébrale.

(1:54 - 2:22)

Donc, l'autorégulation cérébrale va diminuer la résistance vasculaire par phase de dilatation pour compenser la chute de la pression de perfusion cérébrale. Mais cette autorégulation n'est opérationnelle que si la pression de perfusion cérébrale ne dépasse pas 40 mmHg. En dessous de ce seuil, la chute s'amorce et le débit sanguin cérébral devient quasiment nul quand la pression de perfusion cérébrale diminue aux alentours de 20 mmHg.

(2:27 - 2:51)

Donc, il y a d'autres effets systémiques. C'est le classique réflexe duushing qui comporte l'hypotension artérielle, les perverses dilatations, l'hypertension, l'abrasie cardive, l'attaque cardive suivie par l'arrêt respiratoire. Cliniquement, il y a les hypertensions intracrâniennes sans scènes de gravité et les hypertensions intracrâniennes graves.

(2:53 - 3:29)

Pour les hypertensions intracrâniennes sans scènes de gravité, le tableau clinique se résume à quelques céphalées, des vomissements, de l'EDF, voire des convulsions, des déficits de moteur, des troubles visuels. Pour les hypertensions intracrâniennes graves, elles se manifestent par des troubles de conscience, des troubles du tonus, des troubles neuro-végétatifs. Cliniquement, le diagnostic se fait grâce aux scanners et à l'IRM qui peuvent montrer des signes indirects ou diagnostiquer l'étiologie de l'hypertension intracrânienne.

(3:29 - 4:03)

On peut aussi la mesurer, mais c'est un geste qui n'est pas dénué de risque, ce fait dans les centres spécialisés. Pour l'étiologie des HTIC d'installation rapide, il y a l'origine traumatique, les hématomes extrasoduraux, les contusions, les œdèmes diffus. Il y a l'origine vasculaire, l'AVC hémorragique ou ischémique, il y a certains thérapeutiques, et les étiologies peuvent diagnostiquer par le scanner ou l'IRM.

(4:04 - 4:23)

Pour les hypertensions d'évolution, c'est les processus tumours. Il y a aussi l'origine infectieuse, métabolique, les intoxications. Comment on peut intervenir sur le plan thérapeutique? Il faut augmenter la pression de perfusion cérébrale et diminuer la pression intracrânienne.

(4:25 - 5:31)

Comment on peut augmenter la pression de perfusion cérébrale? En augmentant la pression artérielle moyenne grâce à des agents vasopresseurs, grâce au remplissage vasculaire, pour assurer une bonne perfusion cérébrale, éviter le bas débit cérébral et éviter l'ischémie. Pour le traitement, il faut éliminer le volume en excès, la lésion initiale, éliminer une masse expansive, la tumeur, l'hématome, l'abcès grâce à la chirurgie, réduire le volume sanguin cérébral, diminuer le volume du branchement cérébral grâce au manivote, diminuer le volume du LCR grâce à la dérivation interne ou externe du neurocéphalie, voire pratiquer une craniotomie décompressive par un large volet. Et bien sûr, il faut éviter et prévenir tous les facteurs qui risquent d'augmenter la pression intracrânienne, notamment l'osmolarité, assurer une bonne thermorégulation, contrôle de la glycémie, contrôle de la ventilation, contrôler les convulsions, contrôler et corriger toute anémie.